# TEMA 11 · Atención domiciliaria. Epidemiología y vigilancia epidemiológica

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Atención domiciliaria, visita domiciliaria, coordinación, inmovilizados, paliativos e informe de continuidad de cuidados · Bloque B: Método epidemiológico, diseños, enfermedades transmisibles, RENAVE, EDO, SiVIRA y One Health

## Siglas y leyes de este tema

| Sigla o norma | Nombre completo | De qué va |
|---|---|---|
| **AP / AE** | Atención Primaria / Atención Especializada (hospital) | Los dos niveles asistenciales que deben coordinarse |
| **SNS / SMS** | Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud | Sistema público estatal / su servicio de salud en Murcia |
| **Ley 14/1986 (LGS)** | Ley General de Sanidad | Crea el SNS y pone la AP como eje |
| **Ley 16/2003** | Ley de Cohesión y Calidad del SNS | Define las prestaciones comunes (incluida la atención en domicilio) |
| **RD 1030/2006** | Real Decreto de cartera de servicios comunes del SNS | Detalla qué ofrece la AP: atención programada y urgente en el domicilio |
| **Ley 3/2009** | Ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia | Reconoce el derecho a ser atendido en casa |
| **LO 3/2021** | Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (LORE) | Distinta de la sedación paliativa |
| **ESAD** | Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria | Apoya en casa al equipo de AP con pacientes paliativos complejos |
| **ICC** | Informe de Continuidad de Cuidados | Documento que acompaña al paciente en cada cambio de nivel |
| **IMAS** | Instituto Murciano de Acción Social | Servicios sociales de Murcia: dependencia, teleasistencia |
| **NECPAL** | Instrumento para identificar NECesidades PALiativas | Detecta al paciente que necesita cuidados paliativos |
| **PCC / EMAP** | Paciente Crónico Complejo / Estrategia de Mejora de Atención Primaria (Murcia, 2023-2026) | Alerta compartida AP-hospital / plan regional de AP |
| **ABVD / AIVD** | Actividades Básicas / Instrumentales de la Vida Diaria | Las valoran Barthel / Lawton y Brody |
| **UPP** | Úlceras por presión | Riesgo que miden Norton y Braden |
| **RR / OR** | Riesgo Relativo / *Odds Ratio* (razón de ventajas) | Medidas de asociación de cohortes / de casos y controles |
| **RRA / NNT** | Reducción del Riesgo Absoluto / Número Necesario a Tratar | Cuánto evita un tratamiento y a cuántos hay que tratar para evitar un caso |
| **VPP** | Valor Predictivo Positivo | Probabilidad de estar enfermo si la prueba sale positiva |
| **RENAVE** | Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica | Recoge y analiza las enfermedades vigiladas en España (RD 2210/1995) |
| **EDO** | Enfermedades de Declaración Obligatoria | Las que el profesional tiene que notificar a salud pública |
| **CNE / ISCIII** | Centro Nacional de Epidemiología / Instituto de Salud Carlos III | Coordinan la RENAVE |
| **ECDC / OMS** | Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades / Organización Mundial de la Salud | Reciben los datos de España |
| **SiViEs / SIVIET-RM** | Sistema de Vigilancia de España / Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la Región de Murcia | Aplicaciones informáticas para notificar |
| **SiVIRA** | Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda | Vigila gripe, COVID-19 y VRS |

| Sigla o norma | Nombre completo | De qué va |
|---|---|---|
| **IRA / IRAG / VRS** | Infección Respiratoria Aguda / IRA Grave (hospitalizada) / Virus Respiratorio Sincitial | Lo que vigila SiVIRA |
| **ITS / HSH / PrEP** | Infecciones de Transmisión Sexual / Hombres que tienen Sexo con Hombres / Profilaxis Preexposición al VIH | Datos de ITS en aumento |
| **PRAN / AEMPS** | Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos / Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | One Health y uso prudente de antibióticos |

## A1. Concepto, marco legal y objetivos

- **Atención domiciliaria**: actividades sanitarias y sociales en el domicilio para detectar, valorar y seguir los problemas de salud del individuo **y su familia**, potenciando su autonomía. Da respuesta a personas que, **de forma temporal o permanente, no pueden desplazarse al centro de salud**. Enfoque biopsicosocial, comunitario, continuidad y promoción de la autonomía.
- Marco: la **Ley General de Sanidad (Ley 14/1986)** pone la AP como eje; la **Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS** y el **RD 1030/2006 de cartera de servicios** incluyen en la AP la atención **programada** a inmovilizados y la **urgente** a demanda, tanto en consulta como en el domicilio (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliativos). En Murcia, la **Ley 3/2009 de derechos de los usuarios** reconoce el derecho a ser atendido en casa; **Plan Integral de Cuidados Paliativos**.
- Objetivo general: mantener la salud y la calidad de vida en el entorno familiar, **evitar ingresos e institucionalizaciones innecesarias** y apoyar al cuidador. El **sujeto** de atención es el binomio **paciente + familia/cuidador**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **Inmovilizado** = **prevenir** complicaciones (UPP, respiratorias). **Terminal** = **controlar síntomas** y confort.

## A2. La visita domiciliaria

- Actividad propia de la AP (accesibilidad, longitudinalidad = seguimiento a lo largo del tiempo). Puede ser **a demanda (urgente) o programada**; de valoración, seguimiento, educación, técnicas o coordinación. No la hace solo la enfermera (también medicina, trabajo social...). La enfermera es **"invitada"** en el domicilio.
- **Durante la visita** la enfermera **orienta, aconseja, educa y aplica cuidados** (nunca presiona ni obliga a decidir) y, en la fase de desarrollo, aplica **el proceso enfermero completo** (valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar).
- **Indicaciones** (SMS 2023): personas terminales que quieren quedarse en casa, cuando hay que decidir sobre su institucionalización, barreras arquitectónicas... (en todos esos casos está indicada).
- **Etapas (exámenes SMS 2019 y 2022: marca esta)**: **preparación** (revisar la historia y **fijar los objetivos**) → **introducción** (presentarse a la familia) → **desarrollo** (el proceso enfermero) → **registro** → **evaluación**.
- **Etapas según el manual del tema** (modelo de proceso): **captación** → **valoración** → **planificación** → **ejecución** → **evaluación** → **registro** ("Con Valor Puedo Ejecutar Este Reto").
  - **Captación**: derivación de AP (la más frecuente), del hospital (enfermera de enlace, gestora de casos), de servicios sociales o a petición de la familia (validada por el equipo).
  - **Valoración integral**: clínica, funcional (Barthel), cognitiva (MEC, Pfeiffer), ánimo (**Yesavage**), riesgo de UPP (Norton, Braden) y caídas, y **social y familiar** (cuidador, vivienda, **Zarit**). **Revalorar al menos cada 6 meses** si está estable.
  - **Planificación**: diagnósticos, resultados e intervenciones (NANDA-NOC-NIC), objetivos **SMART** (específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazo) consensuados con paciente y familia; plan de cuidados individualizado.
  - **Ejecución**: técnicas, educación, prevención y apoyo psicosocial.
  - **Evaluación**: clínica, funcional, conocimientos, uso de recursos y **sobrecarga del cuidador**.
- **Registro**: en el SMS, mediante el **Modelo 313 (Valoración Integral de Enfermería)** en la historia de AP (OMI-AP/ Ágora), que obliga a cumplimentar las escalas.

| Escala | Valora | Puntuación |
|---|---|---|
| **Barthel** | ABVD (10 actividades) | 0-100; **a menos puntos, más dependencia** (los cortes intermedios varían según la fuente) |
| **Katz** | ABVD (6 actividades) | Letras A (independiente) a G |
| **Lawton y Brody** | AIVD | 0-8 |
| **MEC de Lobo** | Cognición | Deterioro < 24 (< 20 si bajo nivel cultural) |
| **Pfeiffer** | Cognición | Cuenta **errores**: 0-2 normal; 3-4 leve; ≥ 5 deterioro moderado/severo (**5 errores = deterioro cognitivo**) |
| **Yesavage (15 ítems)** | Depresión geriátrica | > 5 sospecha |
| **Norton** | Riesgo de UPP | 5-20; ≤ 14 riesgo; ≤ 12 alto |
| **Braden** | Riesgo de UPP | 6-23; ≤ 16 riesgo; ≤ 12 alto |
| **Arnell** | Riesgo de UPP | Otra escala de riesgo de úlceras |
| **Zarit** | Sobrecarga del cuidador | 22-110; **< 47 no hay sobrecarga** (46 = no); 47-55 leve; > 55 intensa |

**CLAVE PARA RECORDAR**

- En casi todas, menos puntos = peor. Excepciones: **Pfeiffer, Zarit y Yesavage** (más puntos = peor).
- En la **visita inicial al inmovilizado** (SMS 2023) se pasan escalas como Katz, Washington o Arnell; la **escala de valoración familiar de Oviedo no** es de esa visita.

## A3. Coordinación sociosanitaria

- El gran riesgo para el paciente crónico complejo es la **fragmentación** de la atención. Niveles de coordinación: **macro** (planes y acuerdos entre consejerías), **meso** (programas) y **micro** (atención directa).
- Instrumentos: **informe de continuidad de cuidados**, informe de alta, historia clínica compartida (OMI-AP en AP y Selene en el hospital) y comunicación directa. Figuras: comisiones sociosanitarias, **enfermera gestora de casos o de enlace** (coordina recursos; reduce urgencias e ingresos), **ESAD** y equipos de soporte de paliativos, y **trabajador social** (nexo con el **IMAS**: dependencia, teleasistencia).
- El **ESAD apoya y asesora**, pero **nunca sustituye** al equipo de AP, que mantiene la responsabilidad.
- **Hospitalización a domicilio**: procesos **agudos** que requerirían ingreso, tratados en el domicilio (antibioterapia intravenosa, reagudización de EPOC). **Alta precoz**: completar la recuperación en casa. El **ingreso es voluntario**: lo deciden el paciente y su cuidador aunque la unidad lo haya admitido (Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, SEHAD). Más en el tema 12.
- Momento de **mayor riesgo** para la continuidad: el **alta hospitalaria**.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! "Realizar la cura de la UPP" = enfermera de AP. "Coordinar citas, trabajo social y evitar urgencias" = gestora de casos.

## A4. Programas de inmovilizados y de pacientes terminales

### *Inmovilizados*

- Dificultad importante o imposibilidad de salir del domicilio (física, psíquica o social); **total** o **parcial**.
- Objetivos: máxima autonomía, prevenir complicaciones (UPP, musculoesqueléticas, respiratorias, estreñimiento), educar y **apoyar al cuidador**.
- Visitas de seguimiento entre **1 al mes y 1 cada 3 meses** si está estable. **Cambios posturales cada 2-3 horas**, superficies especiales, no masajear prominencias. Revisar la polimedicación.
- Alta del programa: recupera la movilidad, traslado, ingreso en residencia, fallecimiento o rechazo.

### *Pacientes terminales*

- Enfermedad avanzada, progresiva e incurable con pronóstico **inferior a 6 meses** (oncológica o no: insuficiencia cardiaca, EPOC, ELA, demencia). Identificación con el instrumento **NECPAL**.
- Niveles en Murcia: **básico** (equipo de AP, responsable del paciente), **especializado** (equipos de soporte de paliativos y ESAD), **hospitalario** (unidades de paliativos) y **coordinación con urgencias 24 h** (SUAP = Servicio de Urgencias de AP, PAC = Punto de Atención Continuada, y 061).
- Enfermería: dolor con la **escalera analgésica de la OMS**; disnea con oxígeno, **morfina y benzodiacepinas**; **prevenir siempre el estreñimiento con opioides**; cuidados de la boca; curas orientadas al **confort** (no a cicatrizar). Vías: **oral** de elección; si falla, **subcutánea** (nunca intramuscular).
- Ética: consentimiento, instrucciones previas, **adecuación del esfuerzo terapéutico**, **sedación paliativa** (midazolam, ante **síntomas refractarios**, bajando el nivel de consciencia) frente a **eutanasia** (provocar la muerte a petición del paciente, regulada por la **LO 3/2021**).
- **Planificación anticipada de decisiones** (Estrategia de Cronicidad del SNS 2025-2028): **proceso de comunicación** entre profesionales, paciente y entorno para anticipar las decisiones del final de la vida; no es solo rellenar documentos.

## A5. Informe de Continuidad de Cuidados (ICC)

- Documento médico-legal que transmite la información en **cualquier transición** asistencial (alta, derivación a ESAD o paliativos, traslado, ingreso en residencia, servicios sociales), no solo al alta.
- Contenido: identificación y cuidador, información clínica (**alergias y medicación actualizada**, lo "intocable"), escalas, diagnósticos y plan de cuidados, información social y plan de seguimiento.
- **7 características**: completo, claro, **conciso**, preciso, actualizado, accesible y estandarizado.
- Vía de elección: **historia clínica electrónica**. En el SMS se **autogenera** desde Selene; la enfermera pasa de redactora a **validadora** y añade observaciones.
- **Paciente Crónico Complejo (PCC)**: alerta compartida AP-hospital. **EMAP 2023-2026** (Estrategia de Mejora de AP de Murcia): proactividad y liderazgo de la enfermera familiar y comunitaria.

# BLOQUE B · Epidemiología y vigilancia epidemiológica

## B1. Historia natural de la enfermedad y prevención

- **Leavell y Clark (1958)**: dos periodos, **prepatogénico** (tríada **agente-huésped-medio**) y **patogénico** (**subclínico**, bajo el horizonte clínico, y **clínico**, que acaba en curación, cronicidad, incapacidad o muerte).

| Prevención | Actúa en | Objetivo | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| **Primaria** | Prepatogénico | Reducir la **incidencia** (casos nuevos) | Vacunas (p. ej., rubeola en una adolescente), cloración, educación para la salud |
| **Secundaria** | Subclínico | Detección precoz; reducir la **prevalencia** (casos existentes) | **Cribados**, mamografía, prueba del talón |
| **Terciaria** | Clínico | Reducir secuelas, rehabilitar | Rehabilitación |
| **Cuaternaria (Jamoulle, 1986)** | Sistema sanitario | Evitar la **sobremedicalización** y la iatrogenia (daño causado por la propia atención) | Desprescribir, evitar pruebas redundantes |

- **Epidemiología**: estudio de la **distribución y los determinantes** (factores que condicionan la frecuencia) de las enfermedades y estados de salud en **poblaciones** y su aplicación al control. Variables de **tiempo, lugar y persona**. (No confundir con **salud pública**, que es la acción organizada de la sociedad para proteger y promover la salud.)
- **Método epidemiológico**: descriptiva → hipótesis → analítica (verificación) → conclusión → nueva hipótesis.
- **Cadena epidemiológica**: **reservorio** (donde vive y se multiplica), **fuente de infección** (de donde pasa al huésped; en la fiebre tifoidea, el reservorio es humano y la fuente, el agua), **mecanismo de transmisión** (directo: contacto,

sexual, **gotas de Flügge** < 1 m; indirecto: vehículos, fómites, vectores) y **huésped susceptible** (receptivo). Los tres eslabones (fuente, mecanismo y huésped) forman la cadena (SMS 2023).

**TRAMPAS DE EXAMEN**

**! Una mamografía de cribado es prevención secundaria, no primaria.**

## B2. Diseños epidemiológicos y medidas

- **Descriptivos**: **transversal** (prevalencia en un único momento; ambigüedad temporal) y **ecológico** (la unidad es el **grupo**, no hay datos individuales; riesgo de **falacia ecológica**).
- **Sensibilidad** = VP/(VP + FN) (verdaderos positivos entre todos los enfermos); **especificidad** = VN/(VN + FP) (verdaderos negativos entre todos los sanos). En cribado en cascada: primero alta sensibilidad, después alta especificidad. Los **valores predictivos** dependen de la prevalencia (el **VPP sube** si sube la prevalencia).
- **Cohortes**: longitudinal, normalmente prospectivo, parte de la **exposición** (expuestos y no expuestos); permite calcular la **incidencia** en cada grupo y el **RR**. Ideal para exposiciones raras o varios efectos; no para enfermedades raras.
- **Casos y controles**: retrospectivo, parte de la **enfermedad**; ideal para enfermedades **raras** (p. ej., malformaciones), latencia larga o **brotes**; **OR** = ad/bc. **No se puede calcular el RR**.
- **Experimentales** (analíticos no observacionales: el investigador asigna la intervención): **ensayo clínico aleatorizado** (enfermos; manipulación, control y aleatorización; el diseño adecuado para probar si una intervención funciona, p. ej., ejercicio en la depresión), **ensayo de campo** (personas **sanas o en riesgo**; medidas preventivas como vacunas o dietas) y **ensayo comunitario** (la unidad es la comunidad). **Cuasiexperimental**: intervención sin aleatorización (p. ej., prohibir fumar en una comunidad).

| Medida | Fórmula | Cómo se lee |
|---|---|---|
| **Riesgo Relativo (RR)** | Incidencia en expuestos (Ie) / incidencia en no expuestos (Io) | Cuántas veces más riesgo tienen los expuestos (fumadores frente a no fumadores). **RR = 1: no hay asociación**; > 1 factor de riesgo; < 1 protector |
| **Odds Ratio (OR)** | ad/bc | Igual que el RR, en casos y controles |
| **Riesgo Atribuible (RA)** | Ie − Io | Casos debidos a la exposición |
| **Reducción del Riesgo Absoluto (RRA)** | Incidencia del control − incidencia del tratado | Cuánto riesgo quita el tratamiento |
| **Número Necesario a Tratar (NNT)** | **1/RRA** | Pacientes a tratar para **evitar un evento más** que con el control. Estima la **efectividad y magnitud** del efecto. Ej.: 20 % → 10 %: RRA = 0,10, NNT = 10 |
| **Tasa de ataque secundaria** | Casos entre los contactos susceptibles dentro del periodo de incubación / contactos susceptibles | Contagiosidad dentro de un grupo |

**CLAVE PARA RECORDAR**

- Enfermedad rara → casos y controles → OR. Exposición rara → cohortes → RR.

## B3. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia

- **ITS en aumento** (2021-2023): **gonococia +42,6%**, **sífilis +24,1%**, **clamidia** en récord (muy **asintomática** en la mujer: enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad). Más en jóvenes y HSH, por la menor percepción del riesgo (tratamiento antirretroviral, **PrEP**) y el abandono del preservativo. Guías del Ministerio y de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) (Valencia, 2024; horizonte 2030).
- **Infecciones respiratorias**: vigiladas por **SiVIRA** (gripe, COVID-19 y **VRS**). El VRS causa bronquiolitis grave en menores de 1 año (inmunización con **nirsevimab**).

- **Tuberculosis**: descenso lento; amenaza de cepas multirresistentes. Enfermería: **estudio de contactos en círculos concéntricos** y **tratamiento directamente observado**.
- **Campylobacter**: **primera causa de gastroenteritis bacteriana alimentaria** en España (aves de corral, pollo poco cocinado); complicación: **Guillain-Barré**.
- **Tipos de brote**: de **fuente común** (holomiántico, todos se exponen a lo mismo), de transmisión **persona a persona** (prosodémico) y **mixto** (empieza por fuente común y sigue persona a persona, como la **shigelosis**).
- **Encefalopatías espongiformes transmisibles** (priones): llegan al ser humano sobre todo por **consumir productos o tejidos de animales infectados**.

## B4. RENAVE y Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)

- **RENAVE**: creada por el **RD 2210/1995**; coordinada por el **Centro Nacional de Epidemiología** (**ISCIII**). Flujo ascendente: profesional → salud pública de la comunidad autónoma → Ministerio/CNE → **ECDC** → **OMS**. Lista actual de EDO: **Orden SSI/445/2015** (+ COVID-19 desde 2023, Real Decreto-ley 5/2023).
- Vigilancia **pasiva** (espera la declaración), **activa** (busca casos; en alertas y brotes) y **centinela** (muestra de profesionales; p. ej., SiVIRA).
- **Modalidades según la norma** (anexo II del RD 2210/1995, comprobado en el BOE). Los exámenes SMS las preguntan tal cual:

| Modalidad | Enfermedades |
|---|---|
| **Numérica semanal + datos básicos agrupados cada 4 semanas** | Campilobacteriosis, criptosporidiosis, giardiasis, **salmonelosis**, yersiniosis, **hepatitis C**, clamidia, Haemophilus influenzae invasora, **neumocócica invasora**, **encefalopatías espongiformes** |
| **Urgente con datos epidemiológicos básicos** | Cólera, gripe por nuevo subtipo, SARS, **fiebre amarilla**, fiebre del Nilo Occidental, fiebres hemorrágicas víricas, peste, rabia, **difteria**, poliomielitis/parálisis flácida aguda en menores de 15 años, viruela |
| **Semanal con datos básicos** | El resto (tuberculosis, sífilis, gonococia, hepatitis A y B, legionelosis, **enfermedad meningocócica**, sarampión, tos ferina, varicela, paludismo, lepra, dengue, botulismo, COVID-19...) |
| **Informe anual** | **Herpes zóster** |
| **Sistemas especiales** | **VIH/sida** |

- **En la práctica (manual del tema y protocolos)**: además de las urgentes de la tabla, se notifican **en menos de 24 h y ante la mera sospecha**, sin esperar al laboratorio, la **enfermedad meningocócica**, **cualquier brote**, legionelosis, botulismo, carbunco, tétanos neonatal y sarampión (urgente en Murcia desde 2000).
- **Definición de caso**: **sospechoso** (clínica compatible), **probable** (clínica + **nexo epidemiológico**, o pruebas no concluyentes; p. ej., COVID-19 con PCR negativa y serología positiva) y **confirmado** (**laboratorio**).
- **Brote**: **2 o más casos** asociados en tiempo y lugar con una causa común → declaración **obligatoria y urgente** (art. 16 del RD 2210/1995), aunque sea leve.
- **SiViEs**: plataforma informática de la RENAVE (CNE), con anonimización.
- **Murcia**: **Servicio de Epidemiología** (Dirección General de Salud Pública y Adicciones), aplicativo **SIVIET-RM** y Boletín Epidemiológico de Murcia. Desde **2020**: campilobacteriosis, criptosporidiosis, listeriosis, leptospirosis y **dengue como urgente** (por el **mosquito tigre**, *Aedes albopictus*). Vigilancia de **fiebre Q** y leishmaniasis.
- **MoMo** (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria): lo lleva el **CNE (ISCIII)**; vigila la mortalidad por **todas las causas** y la atribuible a la temperatura, con datos del **INE, el Ministerio de Justicia (registros civiles) y la AEMET**. La opción falsa del EIR fue la de su enfoque predictivo («índice Kairos») con predicciones para el día en curso y los siete siguientes.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Hijo de un caso confirmado de tos ferina que empieza con tos = **caso probable**.

! 3 casos leves de conjuntivitis en un colegio = **brote** = declaración **urgente**.

! Fiebre amarilla = **urgente**; salmonelosis, hepatitis C y neumocócica invasora = **semanal con datos cada 4 semanas**; herpes zóster = **anual**.

## B5. SiVIRA, virus emergentes y One Health

- **SiVIRA**: vigilancia centinela todo el año (de la **semana 40 a la 39**); 18 comunidades autónomas y 49 hospitales (30,5% de la población).
  - **IRA en AP**: inicio en los **últimos 10 días** y al menos uno de: tos, disnea, odinofagia o rinorrea (con o sin fiebre).
  - **IRAG** hospitalaria: requiere ingreso de **al menos 24 h** (o muerte en ese plazo); **sin límite de 10 días**. Muestreo sistemático con PCR múltiple; identificación preferente con el **CIP-SNS** (código de identificación personal del SNS).
- Red centinela de Murcia: más de 120 profesionales. En 2023-2024, las mujeres de 20-59 años consultaron por IRA un **68% más** que los hombres (relacionado con la sobreexposición a los cuidados).
- **Fiebre del Nilo Occidental**: flavivirus transmitido por mosquitos ***Culex***; reservorio en **aves**; humanos y caballos son **fondos de saco** (sin transmisión persona a persona ni aislamiento). **Un caso autóctono = brote**. Muestras de **LCR, suero y orina antes del 5.º día** (PCR e IgM por ELISA), no frotis nasal. En una **gestante de parto** infectada debe **valorarse la cesárea** (Plan Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores). La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) excluye a donantes que hayan estado en zona activa en los **28 días** previos (salvo PCR negativa y necesidad urgente).
- **Dengue**: lo transmite *Aedes*; la **prueba del torniquete (Rumpel-Leede)** valora la fragilidad capilar (petequias).
- **Gripe aviar H5N1**: focos en granjas y fauna silvestre; vigilancia de trabajadores expuestos (signo de alarma: **conjuntivitis**); simulacros One Health.
- **Mpox** (viruela del mono): *Orthopoxvirus*; contacto **estrecho piel con piel**, fluidos o fómites; **declaración urgente** por SiViEs.
- **Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico** (tras COVID-19): parecido a la enfermedad de **Kawasaki**, fiebre persistente, puede dar compromiso hemodinámico; **no** se acompaña típicamente de neumonía bilateral.
- **One Health**: interdependencia de la salud **humana, animal y ambiental**. **PRAN** (AEMPS y Ministerio de Agricultura): vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación ("Fleming llorando"). Consumo de antibióticos: **−13% en humanos** y **más del −70% en veterinaria**.

## Otras preguntas del test de este tema

Preguntas del EIR que el reparto automático puso en este tema aunque son de otros (sobre todo vacunas, tema 17):

- **Indicador**: fórmula que mide algo (p. ej., cesáreas por 100 nacimientos); **criterio** = condición que debe cumplir la buena práctica; **estándar** = nivel aceptable del indicador.
- **Ley de cuidados inversos** (atención inversa, Tudor Hart): quien más medios tiene y menos lo necesita es quien más atención consume.
- **Tasa de mortalidad infantil**: muertes de **menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos** en un año.
- Primera **causa externa de muerte en mujeres** en España (INE): **caídas accidentales**.
- **Cartera de AP** (RD 1030/2006): incluye atención a demanda, programada y urgente en consulta y domicilio, paliativos y vigilancia en protección de la salud; la **"información y vigilancia epidemiológica"** como tal es de la **cartera de salud pública**, no de la de AP.
- **Bacteria anaerobia**: *Clostridium botulinum* (no lo son *M. tuberculosis*, *Legionella* ni *Haemophilus*).
- **Escabiosis** (sarna) en casa: lavar la ropa a **≥ 60 °C**, evitar el contacto directo hasta la curación y **no** aplicar el escabicida justo después de la ducha. Lo que **no** se recomienda (EIR) es que toda la familia, incluido el paciente, se aplique permetrina al 5 % "como medida preventiva".
- **COVID-19 y embarazo**: la **OMS mantiene la lactancia materna exclusiva 6 meses** aunque la madre tenga COVID-19; el embarazo **aumenta** la susceptibilidad y el riesgo tromboembólico.
- **Vacuna Comirnaty** (Pfizer): no agitar el vial; puede tener partículas blanquecinas antes de diluir; **proteger de la luz** (nunca guardarla con luz ultravioleta). Campaña 2023-2024: **3 meses** entre la última dosis o infección y la siguiente dosis.
- **Vacuna atenuada**: induce respuesta **humoral y celular** (no necesita adyuvantes).
- **Triple vírica**: a los **12 meses** con refuerzo a los **2 años** (calendario 2023). Varicela con una sola dosis previa: poner **solo la segunda**, sin reiniciar (**nunca se reinicia una pauta**: se respetan edades e intervalos mínimos; varicela desde los 9 meses en situaciones especiales).

- **A los 4 meses** (calendario 2023): **4 pinchazos**.
- **Adulto de 50 años sin historia vacunal**, varicela IgG negativa, fumadora: **gripe, triple vírica, varicela y Td**.
- **Personal sanitario** (2023): triple vírica y varicela si es susceptible, Td si incompleta, **hepatitis B** y **gripe anual** (no hepatitis A).
- **VIH con CD4 < 200**: neumococo, hepatitis B y A, VPH, herpes zóster (vacuna inactivada), **meningococo ACWY** y Td. **VPH** (2023): **HSH hasta los 26 años**.
- **Hemodiálisis / insuficiencia renal avanzada**: **hepatitis B** (calendario 2025); en 2021, neumococo VNP13 + VNP23, hepatitis B y gripe anual.
- **Herpes zóster**: prioridad en hemopatías malignas, trasplantes y fármacos anti-JAK; no en "tumores de más de 20 mm".
- **Rabia preexposición** en inmunodeprimido: **3 dosis, días 0, 7 y 21-28**.
- **Gripe infantil**: **2 dosis** (separadas 4 semanas) si es **menor de 9 años y se vacuna por primera vez**; desde los 6 meses; dosis completa; se puede poner con otras vacunas. Grupo diana 2020-2021: adolescentes con **IMC ≥ 35** (los prematuros eran de 6 meses a 2 años).
- **Tétanos, herida de alto riesgo**: si tiene **menos de 3 dosis** (o no se sabe), vacuna Td + **inmunoglobulina antitetánica**.
- **Alergia al huevo**: contraindicación permanente solo para la **fiebre amarilla**.
- **Certificado internacional exigible**: **fiebre amarilla**, meningococo tetravalente (ACYW135, peregrinos a La Meca) y polio.